EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 96066
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-10-29 13:48:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA MERCEDES RODRIGUEZ GARRIDO			RUN	: 4.509.831-1
F.Nac	: 06-03-1937	Edad	: 87 AÑOS, 7 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: TOMAS YAVAR 554			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 81346238		
Fecha Ingreso	: 2024-10-23	Fecha Egreso	: 2024-10-29 13:48:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J81.X-EDEMA PULMONAR.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria aguda:
- Insuficiencia Cardiaca Descompensada
- EPA recuperado
2.EPOC exacerbado
- Infección por Metapneumovirus / Adenovirus
3. FA en TACO
4. Hipertensión arterial
5. Hipotiroidismo
6. ACV secuelado

Procedimientos Invasivos UTI: Instalación Linea arterial, CNAF (24/10 al 25/10)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I48.0-FIBRILACION AURICULAR PAROXISTICA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. E03.9-HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. B34.0-INFECCION DEBIDA A ADENOVIRUS, SIN OTRA ESPECIFICACION (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. J21.1-BRONQUITIS AGUDA DEBIDA A METAPNEUROVIRUS HUMANO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
8. I50.9-INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de ICC, EPOC, FA en TACO , HTA, Hipotiroidismo ACV secuelar, traída por familiares a servicio de urgencia de HSC el 22/10/24 por cuadro de 2 días de evolución caracterizado por disnea que progresa a ortopnea. A su llegada hipertensa, polipneica, normocardica, polipneica, UMA ++, con estertores bilaterales a la auscultación. Se inicia manejo de paciente en contexto de EPA en urgencias con Furosemida, BIC de nitroglicerina y terapia broncodilatadora. Se realiza reajuste de antihipertensivos, logrando suspender BIC NTG. Se decide ingreso a Medicina. Sin solicitud de evaluación formal por UTI en servicio de urgencias.
Paciente ingresa a Medicina, evoluciona con hemodinamia inestable, se mantiene hipertensa, taquicardica, con mayor requerimiento de FiO2, UMA ++, polipneica, con importante componente obstructivo. Se solicita evaluación por UTI el 24/10. Se decide ingreso de paciente, con techo terapeutico en nuestra unidad. Se rescata panel viral (+) Adenovirus /Metapneumovirus.
Paciente evoluciona en UTI en lo hemodinamico estable, con hemodinamia autosostenida. Se mantiene anticoagulacion con enoxaparina por antecedente de FA. En lo ventilatorio a su ingreso apoyada con CNAF durante primeras 48 hrs, por signologia obstructiva, se apoya con nebulizaciones con bromuro de ipratropio mas corticoides endovenosos con buena respuesta, Se logra destete de CNAF precoz, sin necesidad de

apoyo posterior con FiO2 , se mantiene normosaturando ambiental. En lo infeccioso, ingresa con PPII bajos, se deja cobertura ATB empirica con ceftriaxona azitromicina por sospecha de sobreinfeccion bacteriana por EPOC exacerbado, se mantiene afebril. En lo renal, funcion renal conservada, evoluciona con hipernatremia, que se resuelve con agua libre por boca. En lo metabolico, estable, sin conflicto.
Paciente estable, sin requerimiento de CNAF ni FiO2 desde el 25/10. Se decide HODOM para continuar apoyo con KNT respiratoria

PLAN DE MANEJO:

KNT Respiratoria interdiaria por HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen papilla hiposódica asistida
2. Omeprazol 20 mg 1 comprimido al dia vo
3. Prednisona 20 mg 1 comprimido al dia vo por 2 dias.
4. Bromuro de Ipratropio 4 puff c/6 hrs c/Aerocamara
5. Brexotide (250/25) 2 puff c/12 hrs c/Aerocamara
6. Amiodarona 200 mg 1 comprimido al día vo
7. Bisoprolol 2.5 mg 1 comprimido al dia vo
8. Apixaban 2.5 mg 1 comprimido c/12 hrs vo
9. Sertralina 50 mg 1 comprimido al dia vo (por la mañana)
10. Levotiroxina 50 mcg 1 comprimido al dia vo (en ayunas, 30 minutos antes del resto de otros fármacos)
11. Amlodipino 10 mg 1 comprimido al dia vo
12. Furosemida 40 mg 1 comprimido al día vo
13. Losartan 50 mg 1 comprimido c/12 hrs vo
14. Atorvastatina 40 mg 1 comprimido por noche vo
15. Quetiapina 25 mg 1 comprimido por noche vo
16. Donepezilo 10 mg 1 comprimido al dia vo
17. KNT Respiratoria interdiaria por HODOM

EXÁMENES Y RESULTADOS

29/10/24 crea 0.7 ELP 145/3.5/105 PCR 8.3 GSA pH 7.56, pO2 77, pCO2 35 HCO3 33 (FIO2 21%)
27/10/24: Crea 0.8, ELP 152/4.2/110, HB 11.4, plaq 185000, leucos 7700, PCR 20, pH 7.54, pO2 76, pCO2 42, HCO3 36
26/10/24: Glicemia 175, Alb 3.8, Crea 1.00, Ac. Urico 8.60, Fosforo 2.2, PCR 31, Urea 87, Nu 41, ELP 150/4.10/107, Leuco 6.500, Hcto 34.5, Hb 11.2, Plaquetas 185.000.
25/10/24: Glicemia: 150, Alb 3.8, Crea 1.30, Ca 8.0, PCR 46.9, uremia 96, Bun 45, Mg 1.8, ELP 145/2.8/98, Hcto 33.8%, Hb 11.1, Leuco 3.400, Plaq 190, INR 1.29, Tp 69%, TTPK 37, Ph 7.52, PO2 73, PCO2 48, HCO3 39.

DANIELA VASQUEZ BAHAMONDEZ
MEDICO TRATANTE
16516335-4

JEFE SERVICIO